

Нифедипин

Блокатор кальциевых каналов L-типа · дигидропиридиновый ряд · артериоларный вазодилататор

ФОРМА ВЫПУСКА

таблетки **10 мг**

немедленное

высвобождение

Коринфар · Кордафлекс

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада каналов $\text{Ca}_v1.2$ уменьшает вход Ca^{2+} в гладкомышечную клетку: киназа лёгких цепей миозина не активируется, сокращение не реализуется. Расслабление артериол снижает периферическое сопротивление; преднагрузка не меняется — отличие от нитратов. Те же каналы в миометрии дают токолитический эффект. Барорецепторный рефлекс не подавляется: прирост частоты при 10 мг — 10–15 уд/мин. Начало 10–20 мин, $T_{1/2}$ 2–5 часов.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Тяжёлая преэклампсия (САД ≥ 160 и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст.)	10 мг (1 таблетка)	внутри
При недостаточном эффекте через 20–30 минут	10 мг повторно	внутри
Магния сульфат параллельно (цель противосудорожная)	4 г (16 мл 25 %) за 10–15 мин	в/в
Протокол ACOG, шаг 2 (для сопоставления)	20 мг через 20 минут	внутри
Плановый контроль давления при беременности	ретард 20–60 мг — задача стационара	внутри

Цель 130–150 / 80–95 мм рт. ст., не ниже 100/80. Контроль давления через 20 минут после приёма обязателен. Из трёх первых линий руководств на догоспитальном этапе доступен только нифедипин: лабеталол в укладке нет, инъекционный гидралазин в РФ не зарегистрирован.

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ

Только **внутри**; сублингвально, с раскусыванием или проколом капсулы — исключено: концентрация нарастает быстрее и менее предсказуемо, описаны неконтролируемая гипотензия, инфаркт, инсульт, летальные исходы (Grossman, Messerli, JAMA, 1996).

ОГРАНИЧЕНИЯ И КОНТРОЛЬ

- Гиповолемия и ранее введённые антигипертензивные средства — риск гипотензии
- Магния сульфат не заменяет: снижение давления судороги не предотвращает
- Вне беременности при кризе первым выбором не является — урапидил управляемее
- С магния сульфатом — контроль давления, частоты и рефлексов каждые 5 минут
- Токолиз в РФ — off-label, решение уровня стационара

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Магния сульфат: суммация — гипотензия и нервно-мышечная блокада; антидот магния — кальция глюконат 10 % — 10 мл в/в медленно
- Головная боль первых 30–60 минут, далее ослабевающая — реакция на препарат; нарастающая, со зрительными нарушениями — прогрессирование преэклампсии
- После двух доз эскалации нет: магнезия, реанимационная бригада, эвакуация
- Тератогенность у человека не подтверждена; рекомендован ACOG, NICE, ESC, ВОЗ